

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ERS · ESCALA PARA EVALUAR EL RIESGO SUICIDA

Evaluación psicométrica multidimensional de ideación, dolor psicológico y factores de riesgo autolítico en jóvenes

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Escala para Evaluar el Riesgo Suicida (ERS - 20 ítems)
Autores Originales	Marly Johana Bahamón Muñetón y Yolanda Alarcón-Vásquez (2018)
Procedencia y Ámbito	Universidad Simón Bolívar (Barranquilla, Colombia). Diseñada y validada en español.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico de cribado dimensional de riesgo vital
Población Diana	Adolescentes y adultos jóvenes (12 a 25 años) en contextos clínicos y educativos
Tiempo de Aplicación	4 a 7 minutos (20 reactivos estructurados)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert de 5 puntos: 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo)
Finalidad Clínica	Detección temprana, estratificación del riesgo autolítico, evaluación del sufrimiento psíquico y activación de protocolos preventivos de emergencia en centros de salud y unidades infanto-juveniles

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El suicidio en la adolescencia y primera juventud se articula en una compleja red de factores psicosociales donde convergen la intolerancia al dolor psíquico intenso (**psychache** de Shneidman), la falta de redes de pertenencia social y el colapso de las expectativas de futuro. El diseño de la ERS se fundamentó en la teoría interpersonal-psicológica del suicidio de Thomas Joiner, según la cual el deseo suicida letal emerge de la confluencia entre la percepción de ser una carga para los demás (**perceived burdensomeness**) y la vivencia de aislamiento y pertenencia frustrada (**thwarted belongingness**).

La ERS supera las limitaciones de las escalas unidimensionales de mera frecuencia de ideas autolíticas, integrando cuatro dominios empíricamente validados mediante análisis factorial confirmatorio: la ideación suicida activa y estructuración de planes, el afecto depresivo y desánimo vital, la desesperanza proyectada hacia el futuro y el aislamiento interpersonal percibido. Su brevedad y lenguaje adaptado a la juventud facilitan su aplicación como tamizaje preventivo.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Factor / Dimensión	Nº Ítems	Contenido Clínico Evaluado
1. Ideación Suicida Activa	6 ítems	Pensamientos sobre morir, desear desaparecer, planeamiento letal y fantasías autolíticas.
2. Desesperanza y Dolor	5 ítems	Convicción de que el sufrimiento nunca cesará y falta total de perspectiva de futuro.
3. Expresión Afectiva Negativa	5 ítems	Tristeza profunda, anhedonia, llanto frecuente y sensación de desolación anímica.
4. Aislamiento Social	4 ítems	Percepción de desconexión social, falta de amigos y convicción de ser una carga familiar.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · ERS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach global = 0.89 a 0.92 en muestras comunitarias y clínicas de jóvenes hispanohablantes. Coeficiente Omega de McDonald = 0.91.
Estructura Factorial	Análisis factorial confirmatorio demostró ajuste óptimo del modelo tetrafactorial correlacionado (CFI = 0.952, TLI = 0.941, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.041).
Validez Concurrente	Correlación positiva robusta con la Escala de Ideación Suicida de Beck (BSS, $r = 0.78$), DASS-21 Depresión ($r = 0.72$) y Escala de Desesperanza de Beck (BHS, $r = 0.69$).
Capacidad de Detección	Excelente poder discriminante para identificar adolescentes con antecedentes de gestos autolíticos previos y autolesiones no suicidas (d de Cohen = 1.34).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Escala de Calificación:** Cada ítem se puntúa de 1 a 5 según el grado de acuerdo:
 - Totalmente en desacuerdo = 1 punto
 - En desacuerdo = 2 puntos
 - Neutral / Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos
 - De acuerdo = 4 puntos
 - Totalmente de acuerdo = 5 puntos
- Puntuación Total Compuesta:** Suma simple de las puntuaciones de los 20 ítems.
- Rango de Puntuación:** De 20 a 100 puntos.
- Alerta de Respuesta Crítica:** Cualquier puntuación de 4 o 5 en ítems de ideación suicida activa (Factor 1) anula el valor preventivo de una puntuación global moderada y exige valoración presencial de urgencia.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación ERS	Nivel de Riesgo	Percentil Aprox.	Directriz de Actuación Asistencial
20 a 39 puntos	Riesgo No Significativo	< P60	Población sin indicadores de alarma. Promoción de resiliencia.
40 a 54 puntos	Riesgo Leve / Subclínico	P60 a P79	Malestar emocional difuso; apoyo psicopedagógico y seguimiento.
55 a 69 puntos	Riesgo Moderado	P80 a P92	Ideación pasiva o sufrimiento severo; valoración por salud mental.
70 a 100 puntos	Riesgo Alto / Severo	$\geq$ P93	Alarma vital activa; activación inmediata de código de riesgo suicida.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PUNTUACIONES CRÍTICAS (ERS $\geq$ 55): Una puntuación igual o mayor a 55 puntos sitúa al joven en el percentil 80 de riesgo, exigiendo el establecimiento de un Plan de Seguridad formal, la notificación inmediata a los progenitores o tutores legales y la remoción absoluta de fármacos y objetos cortantes en el hogar.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · ERS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación en Ámbito Educativo o Sanitario: Aplicar ante bajada brusca de rendimiento escolar, ausentismo, autolesiones o aislamiento social.

Paso 2: Evaluación Estratificada del Riesgo:

- **Si ERS < 40:** Orientación escolar habitual. Fomentar habilidades socioemocionales.
- **Si ERS 40-54:** Entrevista individual orientativa. Evaluar acoso escolar (bullying) o problemas de identidad de género y dinamizar soporte familiar.
- **Si ERS ≥ 55 o Ítem de Ideación Activa ≥ 4:**
 1. No dejar al menor a solas bajo ninguna circunstancia.
 2. Contacto urgente con los servicios de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) o urgencias hospitalarias.
 3. Confeccionar Plan de Seguridad de Stanley-Brown identificando señales de crisis, distractores y teléfonos de emergencia (024 en España).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 15 años, estudiante de 4.º de ESO, remitida por el equipo de orientación escolar tras detectarse cortes superficiales en antebrazos cubiertos con muñequeras y un descenso acusado en sus calificaciones.

Evaluación Psicométrica Inicial: ERS Total = 76 / 100 puntos (Riesgo Alto / Severo, Percentil 96).

- **Ideación Activa:** 26 / 30 puntos. Afirma que “a menudo piensa que si muriera todos estarían mejor” y reconoce haber buscado información en internet sobre sobredosis farmacológica.
- **Desesperanza:** 22 / 25 puntos. Convencida de que sus problemas familiares no tienen solución.
- **Aislamiento Social:** 18 / 20 puntos. Se siente excluida por sus compañeras de clase y percibe que “no le importa a nadie”.

Intervención Inmediata: Se activó el protocolo de riesgo suicida del centro escolar y se contactó telefónicamente con su madre para acompañamiento continuado. Fue atendida el mismo día en la USMIJ de referencia, descartándose psicosis y confirmándose un Trastorno Depresivo Mayor moderado reactivo a dinámicas de acoso relacional. Se inició Terapia Cognitivo-Conductual adaptada para adolescentes asociada a fluoxetina (10 mg/día, titulada a 20 mg/día). A las 8 semanas, la puntuación en la ERS se redujo a 32 puntos, sin nuevos episodios de ideación letal.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Preguntar directamente sobre el suicidio no induce la idea (“no produce contagio”); es una intervención protectora vital.
- Cualquier mejoría repentina y sospechosamente alegre tras un período de depresión grave puede indicar calma por decisión suicida firme.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Autolesiones No Suicidas (NSSI):** Cortes o quemaduras con fin de aliviar dolor psíquico insoportable sin intención letal de morir.
- **Depresión Mayor vs Crisis Evolutiva:** Diferenciar la angustia identitaria adolescente de un colapso depresivo endógeno mayor.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Bahamón Muñetón, M. J., & Alarcón-Vásquez, Y. (2018). Diseño y validación de una escala para evaluar el riesgo suicida (ERS) en adolescentes colombianos. *Universitas Psychologica*, 17(4), 1–15.
- Joiner, T. E. (2005). *Why people die by suicide*. Harvard University Press.
- Shneidman, E. S. (1993). *Suicide as psychache: A clinical approach to self-destructive behavior*. Jason Aronson.
- Stanley, B., & Brown, G. K. (2012). Safety planning intervention: A brief intervention to mitigate suicide risk. *Cognitive and Behavioral Practice*, 19(2), 256–264.